SỞ Y TẾ AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH

Chăm sóc người bệnh toàn diện

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVNT ngày / /2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân)

Mã: QĐ-C6.3 · Lần ban hành: 01

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định việc nhận định, phân cấp chăm sóc, đánh giá nguy cơ, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc, phối hợp đa chuyên khoa, giám sát và cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân.
2. Áp dụng cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý, bác sĩ điều trị và nhân viên tham gia chăm sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Chăm sóc toàn diện: chăm sóc đáp ứng nhu cầu thể chất, tinh thần, dinh dưỡng, vệ sinh, vận động, phục hồi chức năng và giáo dục sức khỏe của người bệnh, liên tục trong suốt thời gian nằm viện.
- Phân cấp chăm sóc: việc xếp người bệnh vào cấp chăm sóc I, II hoặc III theo mức độ phụ thuộc vào sự chăm sóc của điều dưỡng.
- Kế hoạch chăm sóc cá thể hóa: kế hoạch được lập cho từng người bệnh theo 5 bước của quy trình điều dưỡng (nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện, lượng giá).
- Gói phòng ngừa: nhóm can thiệp điều dưỡng áp dụng đồng bộ cho người bệnh có nguy cơ cao (té ngã, loét tỳ đè, suy dinh dưỡng, đau).

Điều 3. Nguyên tắc chăm sóc

1. Lấy người bệnh làm trung tâm; chăm sóc liên tục 24 giờ, cá thể hóa theo bệnh lý, tuổi, nguy cơ và khả năng tự chăm sóc.
2. Chăm sóc thể chất (vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng, vận động, theo dõi dấu hiệu sinh tồn, phòng loét tỳ đè, phòng té ngã), chăm sóc tinh thần (giao tiếp, hỗ trợ tâm lý, giải thích điều trị) và chăm sóc phục hồi (hướng dẫn vận động, tự chăm sóc, giáo dục sức khỏe).

3. Người bệnh và người nhà được thông tin và tham gia vào kế hoạch chăm sóc; được tôn trọng quyền riêng tư.
4. Người nhà người bệnh không thay thế điều dưỡng trong thực hiện kỹ thuật chăm sóc.
5. Kỹ thuật chăm sóc thực hiện theo danh mục kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng tại Phụ lục XII Thông tư số 32/2023/TT-BYT, được sửa đổi bởi Thông tư số 25/2026/TT-BYT; kỹ thuật đánh dấu "*" chỉ thực hiện khi có phân công bằng văn bản của người phụ trách chuyên môn.

Chương II. NỘI DUNG CHĂM SÓC

Điều 4. Phân cấp chăm sóc

Phân cấp chăm sóc theo Thông tư số 31/2021/TT-BYT:

Cấp	Đối tượng	Đánh giá lại tối thiểu	Người chịu trách nhiệm
Cấp I	Người bệnh nặng, nguy kịch, hôn mê, suy hô hấp, suy tuần hoàn, phải nằm bất động, cần theo dõi sát; phụ thuộc hoàn toàn vào chăm sóc của điều dưỡng	Mỗi ca trực và khi có thay đổi	Điều dưỡng được phân công; điều dưỡng trưởng khoa kiểm tra hằng ngày
Cấp II	Người bệnh vận động hạn chế, cần điều dưỡng hỗ trợ một phần trong các hoạt động chăm sóc hằng ngày	Mỗi ngày và khi có thay đổi	Điều dưỡng được phân công
Cấp III	Người bệnh tự thực hiện được hầu hết các hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của điều dưỡng	Mỗi ngày	Điều dưỡng được phân công

1. Bác sĩ điều trị và điều dưỡng cùng xác định cấp chăm sóc khi người bệnh nhập khoa, ghi vào hồ sơ bệnh án và phiếu chăm sóc.
2. Đánh giá lại cấp chăm sóc theo tần suất tại bảng trên và khi tình trạng người bệnh thay đổi.
3. Khoa cập nhật bảng tổng hợp cấp chăm sóc hằng ngày tại phòng hành chính khoa.

Ghi chú: *Nguyên văn tiêu chí từng cấp cần đối chiếu Thông tư số 31/2021/TT-BYT trước khi ký (Cần xác minh). Nhóm "chăm sóc đặc biệt" trong tài liệu nội bộ được xếp vào Cấp I.*

Điều 5. Đánh giá nguy cơ bắt buộc

Nguy cơ	Công cụ	Thời điểm đánh giá	Ngưỡng can thiệp
Té ngã	Thang Morse (theo Quy trình phòng ngừa té ngã của bệnh viện)	Trong 8 giờ đầu nhập khoa; hằng ngày với người bệnh có nguy cơ; khi chuyển khoa, sau phẫu thuật, khi dùng thuốc an thần	Morse ≥ 45: nguy cơ cao, áp dụng gói phòng ngừa té ngã
Loét tỳ đè	Thang Braden	Trong 8 giờ đầu; hằng ngày với người bệnh Cấp I, Cấp II	Braden ≤ 18: có nguy cơ; ≤ 12: nguy cơ cao
Suy dinh dưỡng	Công cụ sàng lọc theo Thông tư số 18/2020/TT-	Trong 36 giờ đầu nhập viện; lặp lại hằng tuần	Dương tính: chuyển Tổ dinh dưỡng đánh giá,

Nguy cơ	Công cụ	Thời điểm đánh giá	Ngưỡng can thiệp
	BYT (bệnh viện chọn NRS-2002 hoặc SGA)		can thiệp
Đau	Thang điểm số NRS 0–10; trẻ em: FLACC hoặc Wong-Baker	Khi nhập khoa; mỗi lần đo dấu hiệu sinh tồn; sau can thiệp giảm đau	≥ 4 điểm: báo bác sĩ, can thiệp, đánh giá lại

Ghi chú: *Ngưỡng Morse, Braden là ngưỡng thường dùng trong y văn, Hội đồng Điều dưỡng thống nhất trước khi ban hành. Thời hạn sàng lọc dinh dưỡng cần đối chiếu nguyên văn Thông tư số 18/2020/TT-BYT (Cần xác minh).*

Điều 6. Kế hoạch chăm sóc

1. 100% người bệnh Cấp I, Cấp II có kế hoạch chăm sóc trong 24 giờ đầu nhập khoa theo mẫu BM-C6.3-02; người bệnh Cấp III có kế hoạch chăm sóc rút gọn.
2. Kế hoạch chăm sóc có chẩn đoán điều dưỡng ưu tiên, mục tiêu đo được và có thời hạn, can thiệp cụ thể, lượng giá.
3. Lượng giá ít nhất mỗi ngày và khi diễn biến thay đổi; không ghi chung chung, không sao chép giữa các ngày.
4. Ghi đầy đủ tên người thực hiện, ngày giờ; người bệnh nguy cơ cao được nêu khi bàn giao ca theo ISBAR.

Điều 7. Chăm sóc cơ bản hằng ngày

- Vệ sinh cá nhân, răng miệng, gội đầu, thay quần áo, ga giường theo cấp chăm sóc; người bệnh Cấp I được điều dưỡng, hộ lý thực hiện.
- Hỗ trợ ăn uống, theo dõi khẩu phần theo chỉ định dinh dưỡng; nuôi ăn qua ống thông theo quy trình kỹ thuật.
- Thay đổi tư thế tối thiểu 2 giờ/lần với người bệnh nằm bất động hoặc Braden ≤ 12 (trừ chống chỉ định).
- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn đúng y lệnh và cấp chăm sóc; chăm sóc catheter, ống thông theo quy định kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Hỗ trợ tâm lý, giải thích trước mọi can thiệp; giáo dục sức khỏe và lượng giá hiểu biết người bệnh (teach-back).

Điều 8. Phối hợp đa chuyên khoa

Điều dưỡng chủ động đề xuất và phối hợp với bác sĩ điều trị, Tổ dinh dưỡng, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa Dược theo Quy trình SOP-C6.3-02. Kết quả phối hợp được ghi vào phiếu chăm sóc.

Chương III. GIÁM SÁT, ĐO LƯỜNG VÀ CẢI TIẾN

Điều 9. Giám sát

- Điều dưỡng trưởng khoa: giám sát hằng tuần, tối thiểu 05 hồ sơ/tuần bằng bảng kiểm BM-C6.3-03.

- Phòng Điều dưỡng: giám sát hằng tháng, mỗi khoa tối thiểu 05 người bệnh; ghi kết quả trên phần mềm NT Nursing.
- Khảo sát hài lòng người bệnh về chăm sóc điều dưỡng hằng quý bằng phiếu BM-C6.3-04, tối thiểu 30 phiếu/khoa/quý.

Điều 10. Đo lường chỉ số

Phòng Điều dưỡng tổng hợp 10 chỉ số KPI-C6.3-01 đến KPI-C6.3-10 theo Kế hoạch triển khai, giám sát; các khoa gửi số liệu trước ngày 05 tháng sau theo mẫu BM-C6.3-05; kết quả được báo cáo tại họp Điều dưỡng trưởng hằng tháng và Hội đồng Điều dưỡng 6 tháng một lần.

Điều 11. Cải tiến chất lượng

Khoa có chỉ số không đạt mục tiêu 02 tháng liên tiếp phải phân tích nguyên nhân và có kế hoạch khắc phục (người phụ trách, thời hạn, chỉ số theo dõi). Sự cố liên quan chăm sóc (té ngã, loét tỳ đè, sai sót chăm sóc) được báo cáo và phân tích theo Thông tư số 43/2018/TT-BYT.

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm

- Phòng Điều dưỡng: hướng dẫn, tập huấn, giám sát, tổng hợp chỉ số, đề xuất cải tiến.
- Trưởng khoa, Điều dưỡng trưởng khoa: tổ chức thực hiện tại khoa, phân công điều dưỡng theo cấp chăm sóc, giám sát hằng tuần.
- Bác sĩ điều trị: cùng điều dưỡng xác định cấp chăm sóc, chỉ định phối hợp chuyên khoa.
- Điều dưỡng, hộ sinh, hộ lý: thực hiện đúng Quy định và các quy trình kèm theo.
- Phòng Quản lý chất lượng: phối hợp đánh giá, đưa kết quả vào tự đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện.

Điều 13. Hiệu lực

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các khoa phản ánh về Phòng Điều dưỡng để tổng hợp, trình Giám đốc xem xét sửa đổi, bổ sung.

GIÁM ĐỐC